Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
5ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent5vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5036994-11.2022.8.21.0001/RS

AUTOR: MARGARETE DZIOCH MARCOS

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Vistos.

MARGARETE DZIOCH MARCOS ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA**. Narrou, em síntese, que é beneficiária titular do plano de saúde ofertado pela requerida. Referiu que foi diagnosticada com adenocarcinoma de ovário. Afirmou que está sendo acompanhada pelo médico Carlos Eugênio Escovar, médico oncologista clínico. Referiu que foi prescrito os medicamentos Soliris® (Eculizumabe) e Lynparza® (Olaparibe) para o controle mais adequado da doença. Alegou que a parte ré recusou a solicitação de cobertura do tratamento sob alegação de que o medicamento não está incluso no rol da ANS. Sustentou que o referido fármaco é registrado pela avisa, não sendo off-Label. Discorreu acerca do direito aplicável ao caso. Requereu, liminarmente, a determinação para que a parte demandada forneça o tratamento/cobertura compreendendo aplicação de 300 mg de Lynparza® (Olaparibe) 150 mg. Postulou a procedência dos pedidos para determinar que a parte requerida forneça o fármaco Lynparza® (Olaparibe) 150 mg. Pediu assistência judiciária. Anexou documentos (evento 1, INIC1).

A gratuidade judiciária foi deferida e concedida a tutela de urgência para determinar o fornecimento e aplicações das medicações prescritas, qual seja, 300 mg de Lynparza® (Olaparibe) 150 mg, por tempo indeterminado, bem como invertido o ônus probatório e determinada a citação da demandada (evento 4, DESPADEC1).

A requerida apresentou contestação. No mérito, discorreu acerca da taxatividade do rol da ANS. Sustentou a legalidade da negativa de cobertura. Referiu que o medicamento pleiteado não encontra amparo no rol da ANS de acordo com a diretriz n° 64. Referiu que as medicações nele definidas são restritas, limitando-se o contrato ao fornecimento dos fármacos elencados na referida lista. Aduziu que não há abusividade em sua conduta. Teceu considerações acerca da inversão do ônus probatório. Pugnou a improcedência dos pedidos contidos na exordial. Juntou documentos (evento 12, CONT1).

A parte autora requereu segredo de justiça (evento 17, PET1).

Instadas as partes acerca do interesse na produção de novas provas (evento 18, ATOORD1), ambas manifestaram desinteresse (evento 22, PET1 evento 25, PET1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO.

PASSO A DECIDIR.

Considerando os limites a que se restringiu a controvérsia, dispensável a produção de outros meios de prova, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, no estado em que se encontra o processo (artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil).

Inexistem preliminares pendentes de análise, ao passo que se fazem presentes os pressupostos processuais e as demais condições da ação, devendo-se iniciar o exame do mérito.

Destaco que os planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, salvo as modalidades de autogestão, o que não é o caso dos autos.

Nesse norte, estabelece a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:

> *Súmula 608 – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.*

Com efeito, tratando-se de típico contrato de adesão é manifesta a fragilização do pacta sunt servanda, uma vez que o contrato, embora bilateral, resultou em margem mínima de discutibilidade por parte da aderente, beneficiária do crédito e, nessa condição, inferiorizada contratualmente.

Nesse sentido, é possível a adequação dos contratos de seguros aos ditames legais, de modo a viabilizar, se for o caso, a decretação da nulidade pleno iure das cláusulas que estipulem obrigações consideradas iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, nos termos do artigo 6º, inciso V e artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor[1].

Ainda, acrescento ser um direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre os produtos e serviços disponibilizados no mercado pelos fornecedores. Nesse sentido, preceitua o artigo 6º, inciso III, do Estatuto Consumerista, in verbis:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Para mais.

Consigno que as restrições de direito devem ser expressas, legíveis, claras, sem margem para dúvidas, não podendo ser interpretadas extensivamente em prejuízo do consumidor/contratante, sobretudo, quando se trata de contrato que tem como objetivo a prestação de serviços ligados a saúde das pessoas, consoante art. 6, incisos IV e VIII e art. 47, ambos do CDC[2].

Nesse sentido, é o entendimento do TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. NEFRECTOMIA PARCIAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR. (...) Aliás, sobre o tema, o STJ editou a súmula n. 469, dispondo esta que: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 3. Não há qualquer referência expressa no contrato entabulado entre as partes de exclusão de cobertura de realização de procedimento cirúrgico por videolaparoscopia, serviço que originou a presente demanda. 4.Restrições de direito devem estar expressas, legíveis e claras no contrato, o que não ocorreu no caso em tela, em afronta ao dever de informar consagrado na legislação consumerista. Ressalte-se que a vedação de cobertura não consta taxativamente no contrato, e cláusulas restritivas de direito não dão margem a interpretações extensivas. 5.A omissão no contrato quanto à exclusão de cobertura deve ser interpretada de forma favorável ao consumidor. Inteligência do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. Negaram provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70048874945, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 25/07/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ECOGRAFIA TRANSRETAL DE PRÓSTATA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR. SENTENÇA MANTIDA. Aplica-se o CDC, por se tratar de relação de consumo. Em não havendo qualquer referência expressa no contrato entabulado entre as partes, acerca da exclusão de cobertura de realização do procedimento que o autor necessita realizar, a negativa da operadora se mostra abusiva. As cláusulas restritivas devem estar expressas, legíveis e claras no contrato, sob pena de, em não o fazendo, infringir o art. 47 do CDC. A vedação de cobertura não consta taxativamente no contrato, não podendo tais cláusulas ser interpretadas de maneira extensiva. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70049268527, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em 27/06/2012)

Dessa feita, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável à consumidora, nos termos dos regramentos acima referidos.

Feita estas considerações, passo à análise da controvérsia havida entre as partes.

Na hipótese dos autos, a autora é portadora de adenocarcinoma de ovário e, apresentou recidiva da doença, após quatro meses de tratamento, desenvolveu reação alérgica ao medicamento utilizado (Carboplatina), sendo suspenso o tratamento e prescrito, para o tratamento e manutenção da remissão, o medicamento Lynparza® (Olaparibe) 150 mg, sendo negado pela parte requerida (evento 1, OUT9).

Ainda, saliento que no receituário consta os motivos pelos quais o fármaco Olaparibe foi prescrito (evento 1, OUT9).

Relatório Médico

A paciente Margarete Dzioch Marcos, 53 anos, portadora de Adenocarcinoma de ovário desde 2016, vem em tratamento oncológico com quimioterapia desde então. No presente momento, a paciente apresentou nova recidiva, platino-sensível, tendo realizado 4 meses de tratamento com Carboplatina + Bevacizumab. No entanto, a mesma desenvolveu reação alérgica a platina, motivo pelo qual após 4 ciclos foi suspenso o tratamento. A paciente então necessita realizar tratamento de manutenção da sua remissão, e para tanto solicito associação de bev
acizumab + Olaparibe, conforme artigo publicado em 2012 no NEJM, que embasa a manutenção em pacientes platino sensíveis mesmo sem mutações de BRCA com uso de inibidor de PARP.

O tratamento tem a intenção de aumentar a chance de resposta e remissão da paciente, aumentando seu período livre de doença e melhorando sua qualidade de vida.

Nesse contexto, entendo que o medicamento indicado pelo médico que assiste a paciente não pode ser excluído da cobertura assistencial a ser oferecida pela operadora do plano de saúde, sob pena de desvirtuar a finalidade do contrato entabulado entre as litigantes.

Além disso, o fármaco possui registro na ANVISA e se mostra imprescindível para a boa terapêutica da autora, conforme expressamente elencado no laudo médico. Ademais, considerando que a exclusão de cobertura se mostra abusiva a parte demandada deve fornecer a medicação requerida nos precisos termos do laudo prescrito pelo médico responsável pelo tratamento da beneficiária.

Para mais, entendo que os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence aos médicos que assistem o paciente.

Ainda, sobre o rol taxativo da ANS, friso que tal fato não altera minha convicção.

Explico.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que, **EM REGRA**, o rol da ANS é taxativo. Ou seja, admite-se exceções a critério do Julgador.

O recente julgado:

> *PLANO DE SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS. EXIGÊNCIA DE TERAPIAS DE MÉTODO ESPECÍFICO DE TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL E DE DENOMINADO "ASSISTENTE TERAPÊUTICO". TRATAMENTO EXPERIMENTAL. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL DE COBERTURA. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. JULGAMENTO DA CAUSA, SEM INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA SENTENÇA PARA APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA SEGUNDA SEÇÃO E APURAÇÃO SE A COBERTURA VINDICADA É DE CARÁTER EXPERIMENTAL, ASSIM COMO SE TEM CERTIFICAÇÃO QUE GARANTA A SUA ADEQUADA APLICAÇÃO.*
> *1. A Segunda Seção, por ocasião do recente julgamento dos EREsps n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, pacificou o seguinte: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;*
> *2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.*
> *2. De outro giro, a Segunda Seção definiu também que "estão excluídos das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de plano de saúde os procedimentos clínicos experimentais e o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados (art. 10, I e V, da Lei nº 9.656/1998).*
> *Incidência da Recomendação nº 31/2010 do CNJ e dos Enunciados nºs [...] 26 da I Jornada de Direito da Saúde" (EAREsp 988.070/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, DJe 14/11/2018).*
> *No mesmo diapasão, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo, REsp 1.712.163/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Tema 990, a Segunda Seção pontuou expressamente, inclusive na própria ementa do precedente, ser "lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental".*
> *3. No caso, o Juízo de primeira instância não instruiu o processo, se valendo do relatório do próprio médico-assistente da parte autora, como se fosse nota técnica do NatJus ou laudo de perito regularmente nomeado pelo Juízo, em nítida ofensa ao art. 375 do CPC. Conforme a uníssona doutrina de direito processual civil, à luz do mencionado dispositivo legal, o juiz que tenha formação na área médica não fica autorizado a empregar seu conhecimento especializado, uma vez que "demandas pautadas em questões técnicas sempre demanda a realização de perícia". "[N]ão podem as regras de experiência substituírem a prova pericial na necessidade de demonstração de questão técnica necessária ao julgamento" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos; OLIVEIRA JÚNIOR, Zulmar Duarte de. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015.*
> *São Paulo: Método, 2016, p. 286).*
> *4. Como dito no acórdão do recurso especial repetitivo 1.124.552/RS, julgado pela Corte Especial, o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir que matérias de fato ou eminentemente técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório do caso concreto. Ressaltou-se que: a) cabe franquear às partes a produção da prova necessária à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de cerceamento de defesa e invasão do magistrado em seara técnica com a qual não é afeito; b) sem dirimir a questão eminente técnica subjacente á jurídica, uma ou outra conclusão dependerá unicamente do ponto de vista do julgador, manifestado quase que de forma ideológica, por vez às cegas e desprendida da prova dos autos - em não raros casos simplesmente inexistente; c) nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio de valorações superficiais do julgador acerca de questões técnicas, matéria acerca da qual, em regra, deveria o magistrado se abster de manifestar juízo de valor.*
> *5. Como não houve instrução processual, a tornar, no caso concreto, temerária a imediata solução do litigio para julgamento de total improcedência do pedido exordial, aplicando-se o direito à espécie (art. 1.034 do CPC/2015 e Súmula 456/STF), é de rigor a anulação do acórdão recorrido e da sentença para que seja apurado concretamente, à luz dos parâmetros objetivos estabelecidos pela Segunda Seção supracitados, se a cobertura vindicada é efetivamente imprescindível, assim como se tem caráter experimental, regulamentação e certificação que garanta a sua adequada aplicação, determinando-se o requerimento de nota técnica ao Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem e - na linha do que propugna o Enunciado n. 23 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ - expedição de ofício à ANS, para os esclarecimentos necessários sobre a questão em litígio.*
> *6. Agravo interno parcialmente provido.*
> *(AgInt no REsp n. 1.934.658/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)*

> *AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.* ***1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção desta Corte, o rol da ANS é, em regra, taxativo - ressalvadas excepcionalidades verificadas, através de critérios técnicos, no caso concreto. Precedentes.*** *2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.918.404/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.) grifei*

O caso dos autos se enquadra nas exceções como já pontuado anteriormente.

Assim, entendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida da segurada, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.

Aliás, nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

> *AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. MEDICAMENTO EXPERIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1.* ***O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Precedentes.*** *2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 345.433/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20.8.2013, DJe 28.8.2013) – Grifei -*

Ainda, destaco o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo, em decisão monocrática lançada em Agravo em sede de Recurso Especial:

"A parte demandada tenta eximir-se de sua obrigação, alegando estar o procedimento solicitado pela parte autora fora de cobertura de seu plano de saúde, argumentando para tanto, que se trata de procedimento que não consta no Rol de Procedimentos da Resolução Normativa RN nQ 262 da Agência Nacional de Saúde. Pois bem. Vejamos. Primeiramente, necessário fazer algumas considerações acerca do 'Método Pediasuit'. Este método de fisioterapia intensiva tem grande importância para que as crianças com atraso no seu desenvolvimento motor adquiram habilidades que compensem as deficiências apresentadas, pois o tratamento se foca em auxiliar a criança a maximizar suas funções até explorar todo o seu potencial, proporcionando a aprendizagem de habilidades que só são possíveis com as facilitações geradas por estes dispositivos, ganhando nos aspectos motores e com porta mentais. A criança portadora de deficiência necessita de fisioterapia intensiva para possibilitar o aprendizado ou reaprendizado de habilidades funcionais básicas que lhe facilitarão o cotidiano. Em resumo, o 'Método Pediasuit' é um modo de fisioterapia intensiva para o fim de reabilitação e desenvolvimento psicomotor. Assim sendo, não merece prosperar a tese da parte requerida de que não consta no Rol de Procedimentos da Resolução Normativa RN ng 262 da Agência Nacional de Saúde, eis que da análise da referida resolução encontra-se em seu Anexo 1 previsão de reeducaçao e reabilitação no retardo do desenvolvimento psicomotor. Ademais, da leitura dos autos, das declarações médicas e laudos médicos depreende-se que é extremamente necessário o tratamento com o 'Método Pediasuit' para o desenvolvimento favorável e melhora na qualidade de vida do autor, quando se está diante de um bem maior que é a vida humana. Ressalte-se, ainda, que cabe ao médico decidir qual o melhor tratamento para a evolução clínica de seu paciente". Foram três declarações médicas - ff. 97/99. Quem deve verificar qual o procedimento mais correto para o paciente é o próprio médico e não o plano de saúde. E o médico que possui conhecimento tecnico suficiente. E o medico que conhece o paciente e o melhor tratamento para aquele caso, sob sua responsabilidade. Caso não fosse desta maneira, o médico não exerceria com dignidade e liberdade seu trabalho, estando adstrito ao que o plano de saúde prescreveria. Quanto à cláusula 12.1.2 que estabelece às exclusões de tratamento, é conivente ressaltar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. [...] Visando o equilíbrio na relação contratual é necessário assegurar ao consumidor garantias básicas, dentre as quais a precisa informação sobre os, termos do contrato, afastamento das cláusulas abusivas e interpretação do inserido no pacto de forma que lhe seja mais favorável - art. 47. ***No mais, a saúde, como se sabe, é um bem da vida constitucionalmente protegido, sendo que a busca pela solução da enfermidade, por meio de tratamento mais adequado, que amenize o sofrimento, deve se sobrepor a quaisquer outras considerações. Não é razoável, pois, que o plano de saúde questione o tratamento indicado pelo médico. A posição do Superior Tribunal de justiça é a de que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser ministrado ao paciente. Confira-se, neste sentido: [...] Não podem os planos de saúde se equiparar a negócios jurídicos de efeitos estritamente patrimoniais, pois nele está o direito à saúde e à vida, que é o valor fundamental de toda a ordem jurídica. A justiça contratual é informada pelo princípio da equidade, ou seja, pelo equilíbrio entre prestação e contra prestação.*** *Portanto, desnecessária qualquer discussão acerca do alegado caráter experimental do tratamento, de modo que a confirmação da tutela antecipada concedida liminarmente é medida que se impõe. (e-STJ fls. 322/327). Dessa forma, verifica-se que o entendimento a que chegou o Tribunal de origem, ao determinar o tratamento do segurado, decorreu da interpretação das cláusulas do contrato firmado entre as partes, bem como da análise das circunstâncias fático-probatórias da causa, questões cujo reexame é vedado em âmbito desta Corte, conforme os Enunciados n.º 5 e 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal. Ademais, o acórdão recorrido trilhou caminho alinhado à jurisprudência desta Corte Superior, para quem, "ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano" (AgRg no AREsp 721.050/PE, TERCEIRA TURMA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 09/10/2015). Seguindo a mesma senda, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO INDICADO POR MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA. ABUSO. DANO MORAL VERIFICADO. SÚMULA 83/STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Pretório, é passível de condenação por danos morais a operadora de planos de saúde que se recusa injustificadamente a efetuar a cobertura do tratamento do segurado. 2. O eg. Tribunal a quo seguiu a jurisprudência desta Corte no sentido de considerar que 'a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato' (REsp 183.719/SP, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 13.10.2008). 3. Destarte, o Tribunal a quo decidiu conforme o entendimento desta Corte Superior de que, havendo expressa indicação médica para realização do tratamento, mostra-se desarrazoada sua negativa de cobertura, devendo ser considerada abusiva a cláusula de sua exclusão. [...] 6. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 481.775/DF, QUARTA TURMA, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 21/08/2015, grifo nosso). Assim, o entendimento da Corte local está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que a recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento solicitado por médico especializado para fins de tratamento de doença abrangida pelo contrato é conduta abusiva. (AREsp 885907/PR, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.02/06/2017 - grifei -*

Portanto, considerando que não cabe à demandada determinar o tipo de tratamento que será realizado pela parte autora, esta decisão cabe ao médico que a acompanha e não a operadora do plano de saúde.

Dessa forma, a procedência da demanda é medida impositiva, confirmando a tutela de urgência, reconhecendo a obrigação da ré ao **fornecimento** do medicamento requerido na exordial, em observância aquele efetivamente negado pela requerida (Lynparza® (Olaparibe) 150 mg), pelo tempo em que necessário ao tratamento, conforme prescrito pelo profissional médico que assiste a paciente.

POSTO ISSO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmo a antecipação de tutela e **JULGO PROCEDENTE** o pedido intentado por **MARGARETE DZIOCH MARCOS** em desfavor de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA** para DETERMINAR que a parte ré forneça o fármaco Lynparza (Olaparibe) 150 mg conforme prescrição médica.

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na quantia de 10% sobre o valor da causa, com forte no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Interposto(s) o(s) recurso(s), restará ao cartório, por meio de ato ordinatório, abrir vista à parte contrária para contrarrazões, e, consequentemente, remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Igual procedimento deverá ser adotado na hipótese de recurso adesivo.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE KREUTZ, Juiz de Direito**, em 24/11/2022, às 11:10:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10029294690v18** e o código CRC **6c0c89b3**.

1. Art. 6º São direitos básicos do consumidor:(…)V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:(…)IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; ↩

2. Art. 6º São direitos básicos do consumidor:(…)IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;(…)VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. ↩